

DAC — ATIPIA & DX

Atipia

dispneia, confusão, síncope, fadiga, GI — menos DOR

Síndromes

SCC × SCA; no idoso predomina NSTEMI

ECG + troponina hs

usar DELTA seriado; elevação crônica (DRC/IC/FA) ≠ IAM

Diferente

multiarterial, microvascular, comorbidade, baixa reserva

DAC — TRATAR

SCA inicial

AAS + P2Y12 (clopidogrel no idoso); anticoag ajustada

Invasivo × conserv.

SENIOR-RITA: ↓ IAM não-fatal, não mortalidade → individualizar

Sangramento manda

DAPT mais curta (PRECISE-DAPT); IBP; rever função renal

Crônica/2ª prev.

antianginoso (BB/BCC/nitrato) + estatina/IECA; reabilitação

HIPOTENSÃO POSTURAL

Critério

↓ 20 PAS / ↓ 10 PAD em 3 min (↓ 30 se HAS supina)

Causa pela FC

FC sobe = não-neurogênica; não sobe = neurogênica

Diagnóstico

deitado E em pé (1 e 3 min); ver HAS supina; DD síncope

Red flag

síncope de ESFORÇO = cardíaco (isquemia/EAo/arritmia)

HO — TRATAR (ABCDE)

A / B

Avaliar/retirar fármacos · Beber água+sal (bolus)

C / D

Comportamento (devagar, meias, cabeceira) · Dieta fracionada

Fármaco

midodrina 2,5–10 mg diurna; fludrocortisona (cautela)

HAS supina

cabeceira elevada; vasoconstritor curto diurno; não dosar à noite

AS DUAS FRASES

DAC: “pense isquemia mesmo sem dor” — NSTEMI predomina; invasivo é decisão compartilhada; o sangramento manda. HO: “meça em pé” — não-farm 1º; cuidado com HAS supina.

FRONTEIRA (calibrada)

• Colchicina 0,5 mg [aprovada] ↓ MACE. • Inclisirana [aprovada] ↓ LDL. • Canacinumabe [prova de conceito]. • VERVE [investigacional].